

מדיניות המרכז הרפואי הדסה נוהל הורדת מטופל מקרש גב במחלקה לרפואה דחופה מספר: 03-02-07-01			
הספר: 03, שרותי סיעוד		התחום: 02, עשייה סיעודית	
הנושא: 07, הטיפול בפצועים		הנוהל: 01, הורדת מטופל מקרש גב במחלקה לרפואה דחופה	
מהדורה: ראשונה	פרסום ואשרור: פברואר 2018	עמוד 1 מתוך 6	אישור: אוקטובר 2024
הנוהל נערך ע"י: גב' פנינה שרון, מר אלעד פלס, פרופ' מאיר ליברגל, ד"ר יורם וייל, ד"ר ג'וש שרודר, ד"ר אסף קידר, גב' מרב יוסף.			
הנוהל אושר ע"י: פרופ' יורם וייס מנהל בית החולים עין כרם, דר' תמר אלרם מנהלת בית חולים הר הצופים, דר' שאדן סלאמה מנהלת מלר"ד הר הצופים, דר' קובי אסף מנהל מלר"ד עין כרם, עפרה וקנין מ"מ מנהלת הסיעוד הר הצופים, גילה אלקוקן מ"מ מנהלת הסיעוד עין כרם, אלעד פלס אח ראשי מלר"ד הר הצופים, פנינה שרון אחות ראשית מלר"ד עין כרם			
אישור: גב' פנינה שרון מנהלת חטיבה פנימית ורפואה דחופה			
תחומי האקדמי: AOP 1 (JCI מהדורה 7)			
הנוהל מתייחס לנשים וגברים כאחד			

1. סימוכין

- חוזר מנהל הסיעוד, מספר: 129/17, בנושא: החלטה על הורדת מטופל מקרש גב לאחר תאונת דרכים/חבלות קלות, שפונה למחלקה לרפואה דחופה.
- EMS spinal precautions and the use of the long backboard. Perhaps Emerge Care. 2013 Jul-Sep;17(3):392-3
- EMS Spinal Precautions and the Use of the Long Backboard -Resource Document to the Position Statement of the National Association of EMS Physicians and the American College of Surgeons Committee on Trauma. Perhaps Emerge Care. 2014 Apr-Jun;18(2):306-14
- Ian Stiell MD & el Multicenter prospective of use of the Canadian C-Spine Rule by triage nurses in the emergency department. 2010, CMAJ, 182 (11)

2. נספחים

נספח מספר 1- אומדן מצב הכרה (GCS).
 נספח מספר 2- אומדן והערכה של עמוד שדרה.

3. מבוא

מטופלים לאחר תאונות דרכים/ חבלות קלות מפונים למלר"ד כאשר הם מקובעים לקרש גב וצווארון. קרש הגב נועד למנוע פגיעה בחוט השדרה כתוצאה מהזזת הפצוע במהלך חילוץ ופינוי. הטענה היא שטלטול בלתי מבוקר של פצוע עם פגיעה בלתי-יציבה בעמוד השדרה – עלול לגרום לפגיעה נוספת בחוט השדרה, מעבר לפגיעה שכבר ארעה בעת הפציעה.

כיום ידוע שהקיבוע לקרש הגב גורם לנזקים משניים שונים. נזקים כגון:

- הופעת כאבים והחמרה של כאבים קיימים עקב שכיבה במנח לא נוח על משטח קשיח וישר. כאב זה גורם סבל למטופל הפצוע ויכול גם להוביל לבדיקות והדמיות מיותרות.
- פצעי לחץ- הוכח שלאחר שכיבה של 30 דקות ללא תזוזה על משטח קשיח יש שינוי ברקמה הסקרלית ונוצר פצע.

על כן, מוסכם על כולם שאין יתרון בשכיבה מיותרת על קרש גב.

יש להדגיש כי הנוהל מתייחס אך ורק לקרש גב, ולא לצווארון. למען הסר כל ספק הורדת צווארון והורדה ממיטה לכיסא גלגלים **נשארת** באחריות האורתופד במיון.

4. מטרה

קביעת כללים אחידים וברורים להורדת פצוע מקרש גב על ידי אחות מורשית למתן טיפול ראשוני ומהיר ולמניעת סיבוכים הנלווים לשהייה מיותרת וממושכת של פצועים על קרש גב במלר"ד.

עמוד 2 מתוך 6	נוהל הורדת מטופל מקרש גב במחלקה לרפואה דחופה	03-02-07-01	
---------------	--	-------------	--

5. חלות

רופאים העובדים ברפואה דחופה ואחיות מוסמכות בוגרות קורס על בסיסי ברפואה דחופה, לאחר הכשרתן.

6. הגדרות

- 6.1 מלר"ד-מחלקה לרפואה דחופה (מיון מבוגרים או מיון אמבולטורי).
- 6.2 המורשים להחליט על הורדה מקרש גב לחולה הפונה ליחידה לרפואה דחופה:
 - 6.2.1 רופא- רופא האחראי על הטיפול בחולה במחלקה לרפואה דחופה.
 - 6.2.2 אחות מורשית- אחות מוסמכת בעלת השתלמות מוכרת ברפואה דחופה שעברה הכשרה כנדרש ובעלת הרשאה מהאחות הראשית.
- 6.3 קרש גב- מוצר רפואי המשמש לקיבוע ולהעברה של פצועים כאשר קיימת אפשרות של פגיעה בעמוד השדרה. קרש גב משמש למניעת תזוזה של עמוד השדרה העלולה ליצור נזק בלתי הפיך.
- 6.4 אומדן מצב הכרה (GCS)- מדד ההכרה גלזגו או סולם גלזגו; באנגלית: Glasgow Coma Scale ובקיצור (GCS), הוא מדד נוירולוגי להערכת רמת ההכרה של המטופל. לפי מדד זה, המטופל מוערך על פי מספר קריטריונים קבועים, וסיכום הנקודות מהווה הערכה כללית על פי המדד. תוצאת מדד גלזגו מסייעת לניבוי סיכויי ההתאוששות של החולה (נספח מספר 1).
- 6.5 אומדן להערכת עמוד שדרה- כלי להערכת עמוד שדרה (נספח מספר 2), מתייחס: למצב הכרתו של המטופל, הנעת ארבע גפיים, שלילת כאב או רגישות בעמוד שדרה ושלילת חסרים נוירולוגים סנסורים או מוטורים.
- 6.6 טכניקת "בול עץ"- שיטה להפיכת חולה מצד לצד ללא כיפוף עמוד שדרה ושמירה על עמוד שדרה צווארי.

7. סמכות

- 7.1 בסמכות הרופא המטפל והאחות המורשית להוריד מטופל מקרש גב לאחר ביצוע אומדן בכפוף לנוהל.

8. אחריות

- 8.1 באחריות הרופא והאחות המורשית לבצע אומדן והערכה של עמוד שדרה באמצעות כלי האומדן (נספח מספר 2).
- 8.2 באחריות הרופא והאחות המורשית להדריך את המטופל ומשפחתו בנוגע לטיפול.
- 8.3 באחריות הרופא המטפל והאחות המורשית להוריד את המטופל מקרש הגב על סמך ההנחיות הנלוות והנוהל.

9. אוכלוסיית היעד (להחלטה ע"י אחות מורשית)

מטופלים אשר מפונים למלר"ד אורתופדי, המקובעים לקרש גב, לאחר תאונת דרכים או חבלה קשה ועונים על התנאים הבאים:

- גיל - 18 ומעלה
- אומדן מצב הכרה (GCS) - 15
- מוגדרים על סמך אנמנזה, מנגנון תאונה וכלי אומדן כמתאימים להורדה מקרש גב (נספח מספר 2)

10. קריטריונים לאי הכללה (להחלטה ע"י אחות מורשית)

- ילדים מתחת לגיל 18
- אומדן מצב הכרה מתחת ל- 15 (נספח מספר 1)
- מטופלים תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול
- נפילה מגובה 1 מ' ומעלה
- נפילה מ-5 מדרגות ומעלה
- תאונת דרכים במהירות גבוהה
- תאונת דרכים בה יש נפגע הסובל משברים או מפגיעה המחייבת ניתוח
- תאונת דרכים הכוללת התהפכות או זריקה מהרכב

עמוד 3 מתוך 6	נוהל הורדת מטופל מקרש גב במחלקה לרפואה דחופה	03-02-07-01	
---------------	--	-------------	--

- תאונת דרכים אופנוע או טרקטורין
- שברים בעצמות גדולות
- חבלות משמעותיות בפנים או בגולגולת
- חוסר תקשורת בשל קשיי שפה

11. שיטה

11.1 קבלת המטופל

- 11.1.1 המטופל פונה למלר"ד אורתופדי מקובע לקרש גב.
- 11.1.2 האחות המורשית תבצע קבלה סיעודית כמקובל, תוודא את סיבת הפניה למיון, מנגנון הפגיעה גיל המטופל ומצב ההכרה (GCS- נספח מספר 1).
- 11.1.3 האחות המורשית תשאל ותעריך האם המטופל תחת השפעת סמים ואלכוהול.
- 11.1.4 האחות המורשית תבצע אומדן והערכה של עמוד שדרה (נספח מספר 2).

11.2 שיוך המטופל

- 11.2.1 המטופל מקובע לקרש גב.
- 11.2.2 האחות המורשית תחליט האם המטופל עונה על הקריטריונים להכללה בפרוטוקול, ותדווח ברשומה הסיעודית.

11.3 הפעלת הנוהל

- 11.3.1 האחות המורשית תבצע אומדן והערכה של עמוד שדרה על פי כלי אומדן (נספח מספר 2) ותתעד זאת ברשומת המטופל.
- 11.3.2 במידה והתשובה על כלל הפרמטרים באומדן היא "כן", המטופל מתאים לשיוך לנוהל.
- 11.3.3 במידה והתשובה על אחד הפרמטרים באומדן היא "לא", המטופל ימתין להערכה ראשונית של רופא מטפל.
- 11.3.3 האחות המורשית תדריך את המטופל ומשפחתו. ההדרכה תכלול:
 - מטרת הטיפול- קיצור זמן השהיה על קרש גב עד הגעת הרופא לבדיקה ראשונית.
 - אופן ההוצאה מקרש הגב.
 - המהלך וההנחיות לאחר ההוצאה מקרש הגב.
- 11.3.4 לאחר ביצוע האומדן, במידה ומתקיימים הקריטריונים הנדרשים החולה יורד מקרש גב ע"י שלשה אנשי צוות מורשים, על פי ההנחיות הבאות:
 - שחרור הרצועות המקבעות את הפצוע לקרש הגב.
 - סיבוב המטופל על צדו תוך כדי שימוש בטכניקת "בול עץ" לבדיקת רגישות או סימני חבלה בגב או בעכוז.
 - במידה ואין סימני חבלה או רגישות לאורך עמוד השדרה, הוצאת קרש הגב והשכבת הפצוע על גבו.
 - תיעוד האומדן והורדת הפצוע מקרש הגב ברשומת המטופל.

11.4 המשך ניטור ומעקב

- 11.4.1 לאחר ההורדה מקרש הגב עד בדיקת המטופל ע"י הרופא האחראי: הערכת התפקוד המוטורי והסנסורי (תנועה ותחושה) של הגפיים התחתונות, ע"י האחות המורשית, חצי שעה לאחר ההורדה מקרש גב.
- 11.4.2 תיעוד הממצאים ברשומת המטופל.

12. דיווח ותיעוד

- 12.1 על האחות המורשית לתעד את כל הליך הקבלה, האומדן, ההדרכה, ההערכה, ההתערבות והמעקב ברשומת המטופל.
- 12.2 על האחות המורשית לדווח לרופא המטפל על כל חריגה בהליך התקין של הטיפול.

13. הכשרה והטמעה

- 13.1 הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן באוריינטציה בעת קבלת עובד חדש למחלקה.

עמוד 4 מתוך 6	נוהל הורדת מטופל מקרש גב במחלקה לרפואה דחופה	03-02-07-01	
---------------	--	-------------	--

13.2

העובד החדש יידרש לקרוא ולחתום על קריאת הנוהל.

13.3

עבור אחיות בוגרות קורס על בסיסי ברפואה דחופה מלפני 2018: הטמעת הנוהל, תעשה באמצעות הכשרת האחיות הרלוונטיות, כאשר בסיום יום ההכשרה ייערך מבחן ידע ותתקבל הרשאה אישית מהאחות הראשית לביצוע הפעולה.

14. בקרה

בקרה על יישום נוהל זה תתבצע באופן תקופתי בהתאם לתכניות העבודה של הנהלות בתי החולים/ מנהלי המחלקות / אחיות ראשיות.

נספח מספר 1

טבלת אומדן מצב הכרה (GCS)

פקיחת עיניים	ספונטנית להוראה לכאב אין	4 3 2 1
דיבור	מתמצא מבולבל משמיע מילים משמיע קולות אין	5 4 3 2 1
תנועה	ממלא פקודות ממקם כאב נסוג (לכאב) מכופף (לכאב) מיישר (לכאב) אין	6 5 4 3 2 1

ציון של 15- הכרה מלאה

ציון של 3 - חוסר הכרה

נספח מספר 2

אומדן והערכה של עמוד שדרה

לא	כן	מעל גיל 18
לא	כן	אינו תחת השפעת סמים או אלכוהול בזמן הבדיקה
לא	כן	אין סיפור של אובדן הכרה
לא	כן	אומדן מצב הכרה 15
לא	כן	מניע ארבע גפיים ללא הפרעה
לא	כן	אין תלונה על כאב או רגישות בעמוד שדרה
לא	כן	אין חסרים נוירולוגים סנסורים או מוטורים
לא	כן	תאונת דרכים לא במהירות גבוהה
לא	כן	אין נפגעים אחרים בת.ד. עם שברים או חבלות משמעותיות
לא	כן	תאונת דרכים ללא מעורבות אופנוע או טרקטורון

במידה והתשובה על כלל הפרמטרים באומדן היא "כן", המטופל מתאים לשיוך לפרוטוקול.

במידה והתשובה על אחד הפרמטרים באומדן היא "לא", המטופל ימתין להערכה ראשונית של רופא מטפל.

עמוד 6 מתוך 6	נוהל הורדת מטופל מקרש גב במחלקה לרפואה דחופה	03-02-07-01	
---------------	---	-------------	--